DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: RAFAEL ANTONIO RAMIREZ **Identificación** CC 94190495
Edad: 64 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	ANK	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

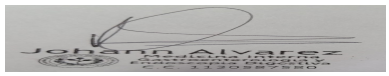
CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K573 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO GRUESO SIN PERFORACION NI ABSCESO
Dx Postoperatorio: I842 HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 14:20:00 **Hora Final** 14:32:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****COLONOSCOPIA****
***INDICACIÓN: Sindrome constitucional
INSPECCIÓN: Normal
TACTO RECTAL: Normal
COLONOSCOPIA: Explorado hasta región cecal (identificando orificio apendicular y válvula ileocecal) observando abundante materia fecal sólida en ciego y colon ascendente que no evacúa a pesar de lavado exhaustivo, sin embargo, en lo valorado, observando múltiples orificios diverticulares sin sangrado, sin edema. No se evidencian signos que sugieran neo, sangrado activo ni reciente en este estudio. Canal anal paquete hemorroidal. Procedimiento sin complicaciones aparentes. Preparación Boston CD: 1, CT: 2, CI: 3 6/9.
***CONCLUSIÓN:
1. DIVERTICULOSIS PANCOLONICA
2. HEMORROIDES GRADO I/IV

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***